

Kultursensibel pflegen



Ein Kompetenzkatalog für beruflich Pflegende

Maria Doukas und Gesa Heinbach

Um *kultursensibel* pflegen zu können, ist es unabdingbar, über fachspezifische Kompetenzen zu verfügen. Die kulturelle Vielfalt von Pflegepersonen wie von Patient_innen initiiert einen Lernprozess hin zu diesen Kompetenzen. Es erfordert ein fundiertes Verständnis von Kultur und Lernen sowie eine gute Aus- und Weiterbildung, integriert in den Prozess der interkulturellen Öffnung des Gesundheitswesens.

In der zwischenmenschlichen Begegnung von Individuen mit ihren vielschichtigen biografischen Prägungen begegnen sich Pflegende und zu Pflegende in einem Arbeitsbündnis. Das Ziel lautet diese Zusammenarbeit effizient, selbstwirksam und in wertschätzender und respektvoller Haltung zueinander anzugehen. Vorurteile und kulturspezifische Klischees stehen diesem Ziel dezidiert im Wege.

Mit Unterstützung durch die Erkenntnisse von Erwachsenenbildung und Kulturwissenschaft kann beschrieben werden, welche Kompetenzen bei allen Beteiligten gefördert werden müssen, um dem Ziel einer kultursensiblen Pflege nahe zu kommen. Bildungsangebote sind dabei von zahlreichen Faktoren der Didaktik, der Politik und der Gesellschaft insgesamt abhängig (Tezcan-Gütekin, 2020) und werden auch nicht die Lösung aller kulturbasierten Probleme in Pflegesituationen sein. Im vorliegenden Text aber wird – basierend auf einer wissenschaftlichen Literaturrecherche – ein erster Kompetenzkatalog für die Aus- und Weiterbildung hin zur kultursensiblen Pflege formuliert, der Grundlage weiterer Entwicklungen sein kann.

Lernen

Ausgehend von einer Vorprägung des eigenen Blickwinkels durch das, was wir bereits erlebt und empfunden haben (Arnold, 2019), beginnt jede Veränderung mit Reflexion über diese Vorprägung. Um einen Lernprozess erfolgreich zu gestalten, braucht es immer die Bereitschaft, sich zu verändern. Es braucht eine „Stop-and-Think-Schleife“ (Arnold, 2008), also einen Moment der Reflexion dieser eigenen, teilweise tief eingetragenen Deutungsmuster, mit denen wir die Welt sehen und interpretieren und daran anschließend eine Änderung unserer Handlungen.

Lebenslanges Lernen ist sowohl Notwendigkeit als auch Freiheit. Es basiert auf Begegnungen, Eigenbedarf, Res-

ourcen und Emotionen sowie Selbststeuerung und profitiert von einem adäquaten erwachsenpädagogischen Konzept in einer fördernden Lernumgebung (Arnold & Rohs, 2014). Denn: „Leben bedeutet deshalb, permanent zu lernen. Leben und Lernen bedingen sich wechselseitig“ (Schäfer, 2017, S.288).

Kultur

Den einen „allgemein gültigen Kulturbegriff gibt es nicht“ (Bolten, 2012, S.10). Dennoch lohnt sich eine Auseinandersetzung mit der Frage, was wir mit Kultur eigentlich meinen: Das Wort verleitet Menschen dazu, Stereotypen zu bilden (positive wie negative), sie nach Ethnien oder Nationen oder einer anderen kulturell definierten Kategorie zu sortieren. Aber der Kulturbegriff schafft auch Orientierung in einer Welt mit vielen Kontakten, und „Kultur“ schafft Zugehörigkeit (Uzarewicz, 2014).

Um damit gut arbeiten zu können, verstehen wir Kultur als ein spezifisches „Ensemble von Deutungs- und Interpretationsmustern“ (Mecheril, 2013, S.26), das dazu führt uns Handlungen nahezulegen, die in diesen Mustern als normal und angemessen gelten. Kultur muss dabei aber immer als veränderlich und unscharf verstanden werden, denn der einzelne Mensch „ist“ nicht seine Kultur, sondern er bringt sie in eine Begegnung mit ein.

Migration und Wissen um andere Kulturen, sich ändernde Zugehörigkeitsgefühle und sich widersprechende Weltanschauungen führen zu sehr individuellen Empfindungen von Fremdheit bzw. Vertrautheit. Auch kulturbedingte Ausgrenzung im Gesundheitsbereich kann aus dieser Vielstimmigkeit resultieren – sei es aufgrund von fremd empfundenem Verhalten oder durch Konflikte auf sozialer oder sprachlicher Ebene. Das Ziel, sich einander zu „entfremden“ (Uzarewicz, 2014), wird auch für Pflegesituationen formuliert: In Bezug auf Kolleg_innen genauso wie auf Patient_innen.

Die Interkulturelle Öffnung im deutschen Gesundheitswesen

„Das Verständnis von Krankheit und Gesundheit ist kulturell unterschiedlich geprägt und kann Einfluss auf das

Gesundheitsverhalten sowie auf medizinische Therapieentscheidungen haben“ (Bauer, 2010, S.8). Diese Unterschiede werden besonders sichtbar zwischen Menschen, die einander kulturell fremd sind – was sich nicht an der Staatsbürgerschaft ablesen lässt. Und auch unter den scheinbar homogenen Anteilen der Gesellschaft ohne Migrationsgeschichte sind im Verständnis von Gesundheit und Krankheit große Abweichungen erkennbar. *Kultur* zeigt sich damit erneut als ein komplexer Begriff, der über statistische Erfassung allein nicht beschrieben werden kann – der aber dennoch beschreibt, dass wir einander unterschiedlich nah sind und uns unterschiedlich gut verstehen können. Auch in Pflegesituationen.

Neben den Patient_innen bzw. Klient_innen zeigt sich kulturbezogene Vielfalt im deutschen Gesundheitswesen auch unter den Beschäftigten, die nach Deutschland kommen oder Deutschland (z.B. Richtung Skandinavien) verlassen (Friebe, 2003). Im ökonomischen Umfeld des deutschen Gesundheitswesens geht es daher bei dem Vorhaben der interkulturellen Öffnung nicht nur um humanitäre Ziele der Pflegepraxis, sondern auch um Arbeitgeberattraktivität und Wirtschaftlichkeit (Behrens, 2011).

Zu einer bedarfsorientierten Personalentwicklung gehören aus beiden Begründungen auch Weiterbildungen für eine kultursensible Pflege, die der Internationalisierung des Berufs gerecht werden. Der interkulturelle Öffnungsprozess deutscher Krankenhäuser beschleunigt sich (Graef-Calliess, 2017) und die Forschung zu diesem Themenfeld bringt stetig neue Erkenntnisse hervor. Dennoch sind sowohl für die kultursensible Pflege als auch für das Arbeiten in multikulturellen Teams viele Fragen ungeklärt – unter anderem hinsichtlich der Aus- und Weiterbildung.

Kompetenzen für eine kultursensible Pflege

Vor dem Hintergrund eines solchen unzureichenden Forschungsstandes, gleichzeitig aber einer viele Jahre dauernden Praxis in der Pflege, soll daher aufgezeigt werden, welche Kompetenzen unserer wissenschaftlichen Literaturrecherche zufolge für eine kultursensible Pflege gebraucht werden.

Kultursensibel bedeutet, die kulturelle Identität von Menschen zu verstehen (Uzarewicz, 2003), sie reflektieren zu können und sowohl als stabilisierend wie auch als veränderbar anzunehmen (Schiffauer, 2002). Dass die Realität davon oft genug sehr weit entfernt ist, wird hier nicht bestritten. Auf der Suche nach einem Kompetenzkatalog, der eine Annäherung an das Ideal einer kultursensiblen Pflege überhaupt erst ermöglicht, arbeiten wir dennoch als Zielpunkt damit. Beispielhaft werden daher vier wichtige Kompetenzen näher betrachtet.

Reflexivität

Reflexion ist die Voraussetzung jedes Lernprozesses. Sie führt dazu, sich und andere zu verstehen. Die Art und Weise, wie wir die Welt sehen, unterscheidet sich immer mehr oder weniger stark von anderen Menschen. Dieser individuelle Blickwinkel macht uns sowohl einzigartig als auch in unserer Wahrnehmung eingeschränkt. Die Kompetenz der Reflexivität ermöglicht es, diese Einschränkung zu minimieren, also offen zu werden für andere Perspektiven. Dadurch erst lassen sich Stereotypen auflösen, negative Fremdheitserfahrungen überwinden und schließlich eine nicht-diskriminierende Pflegesituation schaffen. Beide Kooperationspartner_innen brauchen die Reflexion über ihre jeweilige Prägung:

Welche Erfahrungen habe ich als Patient_in bereits im Krankenhaus gemacht? Habe ich mich eingebunden gefühlt oder wurde über meinen Kopf hinweg entschieden? Wurde ich als Pflegekraft aufgrund meiner Hautfarbe bereits diskriminiert und meine Professionalität infrage gestellt? Habe ich schon einmal schlecht mit einem bestimmten Kulturkreis kooperiert und meine professionellen Handlungen hatten nicht den Effekt, den ich mir gewünscht hätte?

Die Feststellung, dass die eigenen Deutungsmuster einen derartigen Einfluss auf unser Verhalten und unser Gedankengut haben, ist die Basis dafür sie zu überarbeiten und sie in den Kompetenzkatalog für kultursensible Pflege aufzunehmen. Dieser Prozess kann im Rahmen eines interaktiven Austausches über bisherige Erfahrungen in der beruflichen Praxis zwischen Lehrenden und Lernenden in der Pflege angestoßen werden.

Respektvolle Haltung

Patient_in und Pflegekraft oder Mediziner_in müssen sich auf Augenhöhe begegnen, um konstruktiv zusammenzuarbeiten und damit beste Erfolge zu erreichen. Dies geht mit einer gewissen „Ambiguitätstoleranz“ (Witzenleiter & Luppold, 2020, S.5) einher, die Akzeptanz und den Respekt vor Andersartigkeit voraussetzt. Die „Stop-and-Think-Schleife“ nach Arnold (2008) kann durch Reflexion (nicht nur bzgl. kultureller oder ethnischer Bedingungen) zum respektvollen und wertschätzenden Umgang zwischen Patient_in und Pflegekraft beitragen. Um diese Offenheit, Neugier und neutrale, aber aktive Haltung in der Versorgung eines/einer pflegebedürftigen Patienten/Patientin einzunehmen, ist es zwingend notwendig auch negative Emotionen wie Angst, Zweifel und Antipathie zu adressieren, um diese bewältigen zu können (Uzarewicz, 2014). Dies gilt umgekehrt auch für die Patient_innen, die möglicherweise bereits negative Erfahrungen in einem Krankenhausaufenthalt oder mit bestimmten Personen aus dem Pflegeteam gemacht haben. Ein derartiger Konflikt kann nur behoben werden, wenn gegenseitiger Respekt besteht und durch die Aufrechterhaltung dieser Einstellung, auch im Konflikt, Stück für Stück vertieft und

weiterentwickelt werden kann (Bolten, 2012). Die respektvolle Haltung sollte angesichts dieser Bedeutung für die kultursensible Pflege in den Kompetenzkatalog mit aufgenommen werden.

Selbstwirksamkeit

Selbstwirksamkeit im eigenen Dasein ist ein grundlegendes menschliches Bedürfnis und erzeugt Sinn im eigenen Handeln. Die Pflege eines Patienten oder einer Patientin verfolgt das Ziel, dieses Individuum zu unterstützen, zu aktivieren und zur Genesung beizutragen. Diese Pflegemaßnahmen müssen mit dem Wertesystem und dem ethischen Selbstverständnis der Pflegeperson konform sein (Behrens, 2012), sonst können daraus Erschöpfungszustände entstehen (Tegtmeier & Tegtmeier, 2013), die auf fehlender Selbstwirksamkeit basieren: Tagtäglich die eigenen Grundsätzen zu verleugnen schafft Hilflosigkeit und raubt Energie. Das gilt für Pflegenden ebenso wie für Patient_innen – insbesondere, wenn diese zusätzlich mit dem Kontrollverlust durch eine Erkrankung zu kämpfen haben. Abwehrhaltung, Missverständnisse und Verhärtungen können die Folge sein (Schiffauer, 2002). Das menschliche Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit kann dort erfüllt werden, wo alle Beteiligten sich gegenseitig den Raum lassen, diese Selbstwirksamkeit in einer Zusammenarbeit auch zu erleben. Somit braucht kultursensible Pflege die Kompetenz, dies zu ermöglichen. In Aus- und Weiterbildungsangeboten zu kultursensiblen Handeln im Pflegeberuf gilt es somit Selbstwirksamkeit erlebbar zu machen, indem z.B. komplexe Fälle aus der Praxis mit hohem Konfliktpotenzial adressiert und gemeinsam, also mithilfe einer Zusammenführung der verschiedenen Blickwinkel der Lernenden, für alle Beteiligten moralisch und ethisch vertretbar, pragmatisch und zufriedenstellend gelöst werden. Das Bedürfnis der Autonomie der betreffenden Patient_innen sollte dabei im Mittelpunkt stehen und bei allen Maßnahmen berücksichtigt werden. Dozent_innen nehmen in dieser Lernsituation die Rolle eines Moderators oder einer Moderatorin ein.

Kooperation und sozialer Beziehungsaufbau

Jede Lernsituation, jede kulturelle Handlung und jede pflegerische Situation basieren auf sozialer Interaktion. Die Begegnung mit anderen Lernenden oder mit der oder dem Lehrenden, das Interesse an fremden Kulturen und der Kontakt mit Menschen, die z.B. nicht in Deutschland geboren wurden, die Findungsphase einer gemeinsamen pflegerischen Zielsetzung zwischen Patient_in und Pflegefachkraft – dies alles sind mögliche Bestandteile unseres privaten und beruflichen Alltags. Die Kompetenz zur Kooperation im sozialen Geflecht ist ein zentraler Bestandteil informeller und formeller Lernprozesse, da Menschen in jedem Fall voneinander lernen (Bolten, 2012). Je größer die Divergenz zwischen den kommunizierenden und ko-

operierenden Partner_innen ist, desto größeres Konfliktpotenzial besteht. Können diese durch Kompetenzen wie Reflexivität oder Selbstwirksamkeit überwunden werden, verbergen sich Entwicklungspotenziale hinter jeder zwischenmenschlichen Begegnung und Beziehung. Diese Potenziale zu sehen und für einen guten Verlauf der Pflege nutzbar zu machen ist eine weitere Kompetenz, die dem Katalog für eine kultursensible Pflege hinzugefügt werden soll.

Fazit

Die Kompetenzen stellen Grundlagen dar, die dann zur persönlichen Weiterentwicklung, zu bewusstem kultursensiblen Handeln und zu einem professionellen Pflegeverständnis beitragen. Werden diese und ggf. weitere Kompetenzen zusammengeführt, so entsteht ein Anforderungsprofil für die Ausbildung und Weiterbildungen, die dem langfristigen Ziel einer kultursensiblen Pflege in Deutschland dienen. Dieser Prozess beginnt punktuell vor allem auf praktischer Ebene – aber zielgerichtet gesteuert werden muss er von der Führungsebene. Sie muss dieses Prinzip nicht nur glaubwürdig in ihrer Vorbildfunktion leben, sondern in die Abläufe der Mitarbeitenden adaptieren und partizipativ einführen und festigen (Hundenborn et al., 2018).

„Die Entwicklung einer eigenen Wertebasis, die bewusste Arbeit an den eigenen Einstellungen und Haltungen, ist ein Anspruch in allen Bildungsprozessen“ (Hundenborn et al., 2018, S.35). Vereinzelte Fortbildungen für einzelne Mitarbeiter_innen können dabei nicht das Mittel der Wahl sein. Die Etablierung eines oder einer *Migrationsbeauftragten* nach Empfehlung der Praxisratgeber des bundesweiten Arbeitskreises Migration und öffentliche Gesundheit (Graef-Calliess et al., 2021) könnte eine unterstützende personelle Ressource darstellen.

Der gesamte Prozess hin zu einer kultursensiblen Pflegepraxis könnte durch unterschiedliche Qualifikationen innerhalb eines verantwortlichen Teams verstärkt werden, um unterschiedliche Perspektiven fortlaufend präsent zu haben. Die Verknüpfung von Ausbildung, Weiterbildungen, Organisationsentwicklung und Pflegepraxis ist dabei von hohem Wert – begleitet von Reflexionsmöglichkeiten (z.B. Supervisionen) und einer Unterstützung durch die Leitungsebene. So könnte auch der Kompetenzkatalog erweitert und angepasst werden.

Literatur

- Arnold, R. & Rohs, M. (2014). Von der Lernform zur Lebensform. In K. W. Schön herr & V. Tiberius (Hrsg.), *Lebenslanges Lernen: Wissen und Können als Wohlfaktoren* (S. 21 – 28). Springer VS.
- Behrens, B. (2011). Interkulturelle Öffnung im Gesundheitswesen: Überblick – Strategie – Praxis. In R. Leiprecht, I. Petersen & W. Schulz-Kaempff (Hrsg.), *Schriftenreihe des Interdisziplinären*

- Zentrums für Bildung und Kommunikation in Migrationsprozessen (IBKM) an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (Bd. 55). Carl Hanser Verlag. <https://d-nb.info/1013082893/34>
- Bolten, J. (2012). *Interkulturelle Kompetenz* (Revised Aufl.). Landeszentrale für politische Bildung. Thüringen.
- Graef-Calliess, I. T., Koch, E., Gün, A. K., Herbig, N., Marquardt, J., Naimi, I., Scheffer, B., Staudt, J., Wächter-Raquet, M. & Wesselmann, E. (2021). *Das kultursensible Krankenhaus: Ansätze zur interkulturellen Öffnung* (2. Aufl.). Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration.
- Schäfer, E. (2017). *Lebenslanges Lernen: Erkenntnisse und Mythen über das Lernen im Erwachsenenalter (Kritisch hinterfragt)*. Springer.
- Tezcan-Gütekin, H. (2020). Diversität und Pflege: Zur Notwendigkeit einer intersektionalen Perspektive in der Pflege. In D. Auth, T. Noetzel & M. K. Döbler (Hrsg.), *Pflege: Praxis – Geschichte – Politik* (S. 250 – 265). Bundeszentrale für politische Bildung.
- Uzarewicz, C. (2003). Überlegungen zur Entwicklung transkultureller Kompetenz in der Altenpflege. In J. Friebe & M. Zalucki (Hrsg.), *Interkulturelle Bildung in der Pflege* (S. 29 – 46). Bertelsmann.
- Witzenleiter, H. & Luppold, S. (2020). *Quick Guide Interkulturelle Kompetenz: Interkulturelle Sensibilisierung für eine grenzenlos erfolgreiche Kommunikation*. Springer Gabler.

Die Gesamtliteratur kann bei den Autorinnen angefragt werden.



Maria Doukas, M.A.

Stellvertretende Schulleitung
Berufsfachschulen für Pflege und
Krankenpflegehilfe der Akademie
für Gesundheitsberufe am Universi-
tätsklinikum Augsburg

maria.doukas@uk-augsburg.de



Dr. Gesa Heinbach

Leitung des Zentrums für lebens-
langes Lernen an der Universität
des Saarlandes

g.heinbach@univw.uni-saarland.de